

Pętla unikania, jak w fobii — *ekspozycja przerywa cykl*

Pacjent unika jedzenia → lęk się wzmacnia → „groźność” utrzymana. Stopniowa ekspozycja przerywa pętlę. Bez ekspozycji nie ma generalizacji.

CZAS: 8–12 sesji, 6–12 miesięcy procesu

REALIZACJA: faza 2 CBT-E (sesje 10–20), po regulacji jedzenia i pracy z regułami

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, rozdz. 9); Steinglass i in. (2012/2014, *Int J Eat Disord*); Bowlby i in. (2015, *Cogn Behav Pract*); Waller i in. (2007)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **mechanizm pętli unikania** w AN (analogia do fobii) i lista typowych *fear foods*. Sekcja 02 — **dziesięć kroków protokołu**: od listy do powtarzanej ekspozycji bez kompensacji. Sekcja 03 — **hierarchia ekspozycji** do wypełnienia z pacjentem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

„Fear foods” — jedzenia unikane z powodu intensywnego lęku („przytyję”, „stracę kontrolę”). Pętla unikania analogiczna do fobii: unikanie → wzmocnienie lęku → utrzymanie „groźności”. Rozwiązanie: **hierarchiczna ekspozycja** — lista 20–40 pozycji, ocena SUDS 0–10, start od poziomu 3–5, każde jedzenie powtarzane 5–10 razy do habituacji. **Krytyczna zasada — bez kompensacji**: po ekspozycji nie pomijamy posiłku, nie ćwiczymy dodatkowo, nie ważymy się. Kompensacja blokuje uczenie się (Steinglass i in., 2012, 2014).

01 Pętla unikania — dlaczego sama silna wola nie wystarczy

PĘTLA, KTÓRA UTRZYMUJE STRACH

Unikanie → wzmocnienie lęku → „groźność”.

Pacjent unika pizzy → kolejny raz unika → trzeci raz unika → pizza staje się „jeszcze groźniejsza”. Bez ekspozycji *nie ma* nauki, że jedzenie *nie* jest niebezpieczne.

MECHANIZM WYJŚCIA — HABITUACJA

Powtarzanie ekspozycji wygasza lęk. Pacjent zjada pizzę → lęk SUDS 8 → po 1h spada do 4 → po kilku powtórzeniach max SUDS 3, później 1. Mózg uczy się: „to nie jest zagrożenie”.

Typowe *fear foods* w AN: słodczyce, ciasta, czekolada, chleb, makarony, pieczywo, tłuszcze (masło, oliwa, awokado), mięso, nabiał pełnotłusty, fast food, pizza, lody. Lista pacjenta ma zwykle **20–40 pozycji**. Cel: po terapii pacjent może *jeść je wszystkie* bez intensywnego lęku — *nie „lubić”* wszystkiego (nadal może mieć preferencje), ale *móc wybrać*.

Krytyczna zasada — bez kompensacji. Po ekspozycji pacjent *nie pomija kolejnego posiłku*, *nie ćwiczy dodatkowo*, *nie waży się*. Kompensacja blokuje uczenie się — mózg dostaje sygnał: „to było zagrożenie, na szczęście je zneutralizowałem”.

1. **Lista fear foods** — „Wypisz wszystkie jedzenia, których unikasz lub które budzą lęk”. Cel: 20–40 pozycji. Bądź konkretny — nie „słodycze”, lecz „ciastko z kremem”, „pączek”, „lody czekoladowe”.
2. **Ocena lęku (SUDS 0–10)** — dla każdego jedzenia. 0 = brak lęku, 10 = najmocniejszy możliwy. Uporządkuj od najniższego do najwyższego.
3. **Wybierz pierwsze 3–5 pozycji** — z oceną 3–6. Nie 8–10 (zbyt trudne, ryzyko niepowodzenia). Nie 1–2 (za mało wyzwania). Strefa „wyzwania, ale wykonalności”.
4. **Plan ekspozycji nr 1** — konkretne jedzenie, konkretna porcja, konkretne miejsce, konkretny czas. Przykład: „Czwartek 15:00, w kawiarni „Zacisze”, zjem pączek z dżemem, popiję kawą z mlekiem”. Ustal też: kto obok (terapeuta? rodzina? sam/a?).
5. **Przed ekspozycją — przewidywania** — „Co przewiduję, że się stanie? SUDS 0–10 przed? Po?” Pacjent zapisuje. To kluczowe — pozwala później porównać przewidywanie z rzeczywistością.
6. **W trakcie** — pacjent zjada. Notuje SUDS co 10–15 min przez 1–2h po zjedzeniu. Nie ucieka — siedzi, obserwuje, jak SUDS spada.
7. **Bezpośrednio po — bez kompensacji** — nie pomija kolejnego posiłku, nie ćwiczy dodatkowo, nie waży się. To kluczowe — bez tego nie ma uczenia się (habitacji).
8. **Omówienie na sesji** — „Przewidywanie vs rzeczywistość. Co naprawdę się stało? Jak SUDS się zmieniły?” Zwykle: max SUDS 5–8, potem spadek do 2–4 po 1h. Nikt nie „przytył” po jednym pączku. Lęk zmaleł.
9. **Powtarzanie 3–5 razy** — każde jedzenie trzeba „przepracować” wielokrotnie. Po 5 powtórzeniach SUDS zwykle spada do 1–2. Wtedy wchodzi następne jedzenie (kolejny poziom hierarchii).
10. **Stopniowe zwiększanie trudności** — co 2–4 tygodnie poziom wyżej. Cały proces 8–12 sesji. Nie spieszyć się — szybkie skoki = niepowodzenie i wzmocnienie lęku.

LP.	JEDZENIE (KONKRETNIE)	SUDS 0–10	PLAN EKSPOZYCJI (GDZIE, KIEDY, Z KIM)
1			
2			
3			
4			
5			

Klucz: lista fear foods ewoluuje — niektóre znikają (bo przestają być straszne), nowe się ujawniają (bo zauważone). To *dobry znak*. Cel terapii: pacjent może *jeść co chce* bez intensywnego lęku. Nie: „lubić wszystko” — nadal może mieć preferencje. Tak: elastyczność wyboru jest możliwa.

Komunikat dla pacjenta: „nie chodzi o to, żebyś polubił/-a wszystko. Chodzi o to, żebyś mógł/mogła jeść to, co chcesz, bez paraliżu lęku. Wybór ma być Twój — nie AN”.

⚠ **Koordinacja z rehabilitacją:** u pacjentów z bardzo niską masą ciała ekspozycje fear foods muszą być skoordynowane z procesem rehabilitacji żywieniowej i monitorowaniem medycznym. Wprowadzenie dużych porcji wysokokalorycznych pokarmów u pacjenta z BMI <14 bez kontroli refeedingu = realne ryzyko medyczne. Hierarchia ekspozycji w fazie wczesnej zaczyna się w obrębie normalnych porcji planu diety.